

Autoestima: evaluación e intervención

Marco clínico para profesionales de salud mental

MARCO CONCEPTUAL: AUTOESTIMA Y CREENCIAS NUCLEARES (BECK)

La autoestima baja suele organizarse en torno a creencias nucleares negativas sobre el self ('soy defectuoso/a', 'no soy suficiente', 'no soy querible'). Estas creencias activan sesgos atencionales y confirman la narrativa negativa. El trabajo clínico apunta a identificarlas, cuestionar su evidencia y construir narrativas alternativas.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Creencias nucleares

Explorar con flecha descendente. ¿Qué significa para vos ese error? ¿Y eso qué dice de vos?

Distorsiones cognitivas

Personalización, sobregeneralización, filtro mental, descalificación de lo positivo.

Origen del patrón

Experiencias tempranas, figuras de apego críticas, comparación crónica, bullying.

Impacto funcional

Evitación, dependencia de aprobación, dificultad para establecer límites, perfeccionismo.

Recursos existentes

Áreas de autoeficacia, red de apoyo, logros pasados. Construir desde lo que hay.

INTERVENCIONES CON EVIDENCIA

TCC — Reestructuración de creencias nucleares

Registro de creencias, experimentos conductuales, técnica de la flecha descendente. Fennell (1997).

ACT — Defusión y yo-contexto

Separar el self de la narrativa negativa. 'Tengo el pensamiento de que soy un fracaso' vs 'soy un fracaso'.

Terapia de autocompasión (MSC)

Programa estructurado basado en Neff & Germer. Alta evidencia en reducción de autocrítica y vergüenza.

Activación conductual

Acciones alineadas con valores generan evidencia de capacidad. Más efectivo que el trabajo cognitivo puro.

■ Clave clínica:

La autoestima baja rara vez es el problema principal: suele ser el resultado de experiencias de invalidación, crítica crónica o falta de afecto. Trabajar solo el pensamiento sin atender el origen suele ser insuficiente.